Nome: Frederico	**Data:** 18/07/2026
Espécie: Canina	**Sexo:** M
Raça: Buldogue Francês	**Idade:** 4 meses
Peso: 5,45	**Porte:** P
Veterinário Dr (a): Dra. Laiz (Acr Cunha)	
Responsável Sr (a): Bruno Nogueira	

Laudo

Laterolateral direita, Laterolateral esquerda, Ventrodorsal de **Tórax**

HISTÓRICO:
Paciente esta com secreção nasal e com tosse.

SINAIS CLÍNICOS:
Suspeita de Pneumonia.

SUSPEITA CLÍNICA:
Avaliação de Tórax.

Os dados supracitados neste laudo, são oriundos e de responsabilidade da clínica veterinária requisitante.

DESCRITIVO

Tórax

- Corpos vertebrais em forma de cunha T7, T e T11, fusão de processos espinhosos de T6-T7 e T8 (1);

- Traqueia pérvia, com diâmetro diminuído ao comparativo do diâmetro da primeira costela (< 1,5 x) (2);

- Carina da traqueia e região sem sinais dignos de nota;

- Mediastino de aspecto radiográfico preservado, sem sinais de formação ou pneumomediastino;

- Trajeto esofágico de aspecto radiográfico habitual e sem presença de corpos estranhos radiopacos;

- Cúpula diafragmática alinhada, regular e dividindo as cavidades torácica e abdominal;

- Silhueta cardíaca de aspecto globoso e com dimensão aumentada (VHS = 12,8 v.; VLAS = 2,7 v.) (3);

- Aorta torácica e veia cava caudal com densidade radiográfica preservada, diâmetro habitual e trajeto preservado;

- Espaço pleural preservado, sem presença de ar e/ou conteúdo líquido, sem alterações para este estudo;

- Seios costofrênicos de morfologia preservada, sem alterações radiográficas;

- Brônquios principais pérvios com luz diminuída com paredes radiodensas, vasos pulmonares de diâmetro usual e trajetos obliterados e campos pulmonares pouco aerados com presença de broncogramas aéreos, com radiodensidade pulmonar aumentada em padrões bronquial difuso, intersticial não estruturado difuso e alveolar, para a técnica (4);

- Região dos linfonodos mediastinais, esternais e traqueobrônquicos preservados, sem sinais de linfadenopatia/linfadenomegalia;

- Região axilar direita e esquerda preservadas para o método;

- Parede torácica preservada, sem alterações dignas de nota para a técnica;

- Fígado com dimensão preservada para a idade;

** A avaliação específica para traqueia deve ser feita na inspiração e na expiração, pois, devido ao movimento respiratório, a mesma pode ficar com o diâmetro maior (inspiração) ou menor (expiração). No exame radiográfico é possível apenas estimar o grau do possível colapso, sendo necessário traqueoscopia para diagnóstico definitivo.*

*** Valor de referência para VHS em cães: 8.5 a 10.5 vértebras*
**** Valor de referência para VHS em gatos: 7,5±0,3 vértebras*
***** Valor de referência para VLAS: 1,3 a 2,2 vértebras*

Outros achados

- Nada digno de nota.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

- Os achados visibilizados ao presente estudo são suspeitos e/ou compatíveis com:

1 - Más formações congênitas, vértebras em cunha e fusão de processos espinhosos, comum para a raça;

2 - Hipoplasia traqueal é sugerida;

3 - cardiomegalia pode ser associada a más-formações congênitas, persistência de ducto arterioso é o mais prevalente, com diferencial para outras cardiopatias ou ainda efusão pericárdica;

4 - Broncopneumopatia sugere edema pulmonar, com diferencial para processos infecciosos;

RECOMENDAÇÕES E/OU SUGESTÕES:

- Ecocardiografia, endoscopia de vias aéreas são recomendados;

- A realização das recomendações e/ou sugestões, ficam a critério do médico veterinário responsável pelo paciente. Normalmente as recomendações/sugestões tem o intuito de auxiliar nos diagnósticos diferenciais.

OBSERVAÇÕES:

- A análise isolada deste exame não tem valor diagnóstico. O valor preditivo de qualquer exame precisa ser avaliado em conjunto com os dados clínicos do paciente, como histórico clínico, sinais clínicos e evolução do quadro clínico, além dos dados epidemiológicos e a avaliação conjunta de outros exames complementares.

- A ausência de informação do paciente como idade, histórico, sinais clínicos e suspeitas clínicas, prejudicam a impressão diagnóstica pelo médico veterinário imaginologista, pois alterações de imagem semelhantes, podem significar diagnósticos clínicos diferentes. Essa observação é válida apenas nos casos de ausência das informações necessárias.

- É possível que achados incidentais sem conotação patológica não sejam relatados no laudo, ou fiquem descritos no tópico "outros achados".

Assinado digitalmente em: Jul 19 12:35:35 BRT 2026

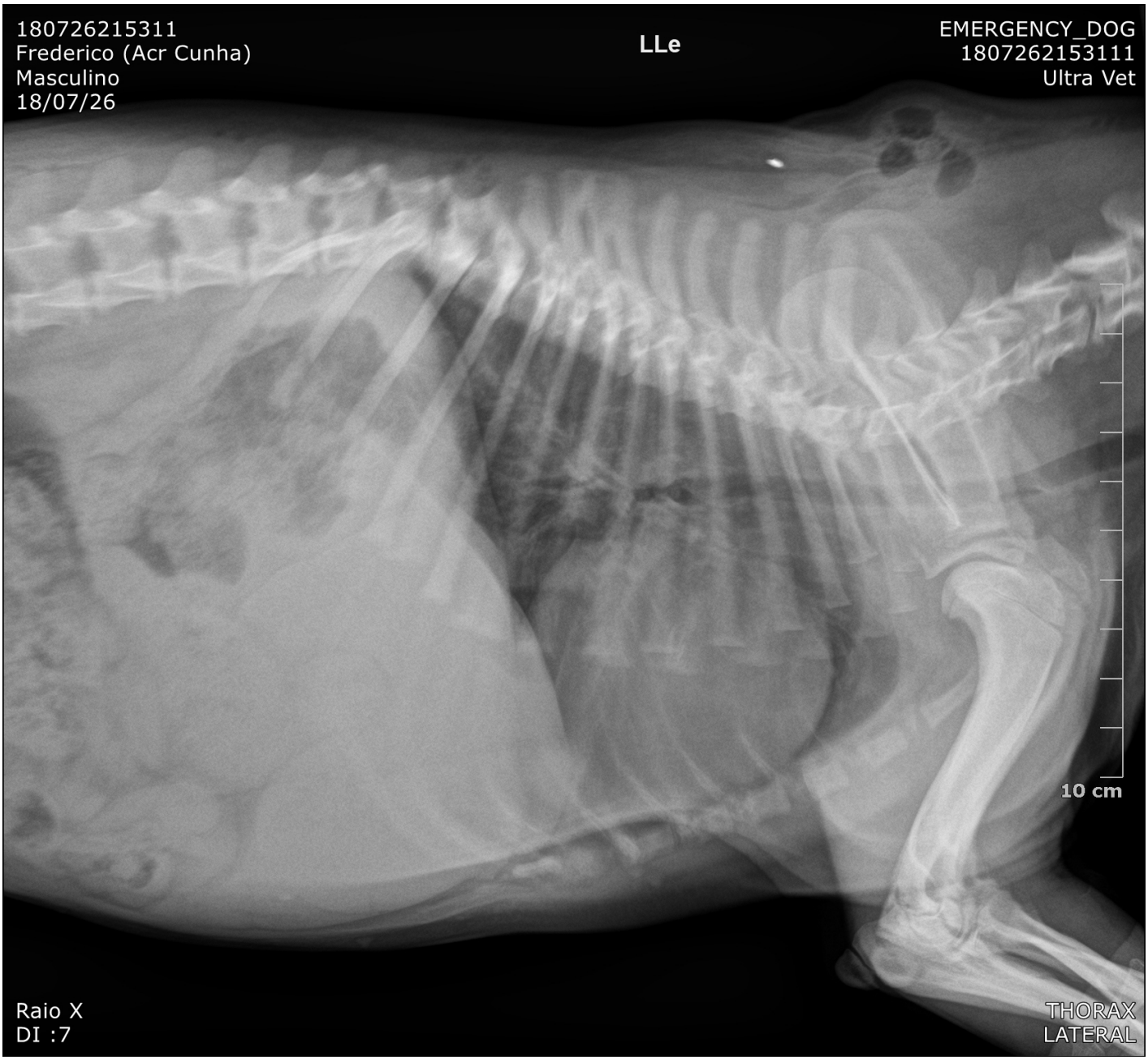


Prof. Dr. Pedro Marchan

Médico Veterinário CRMV-PR 6942

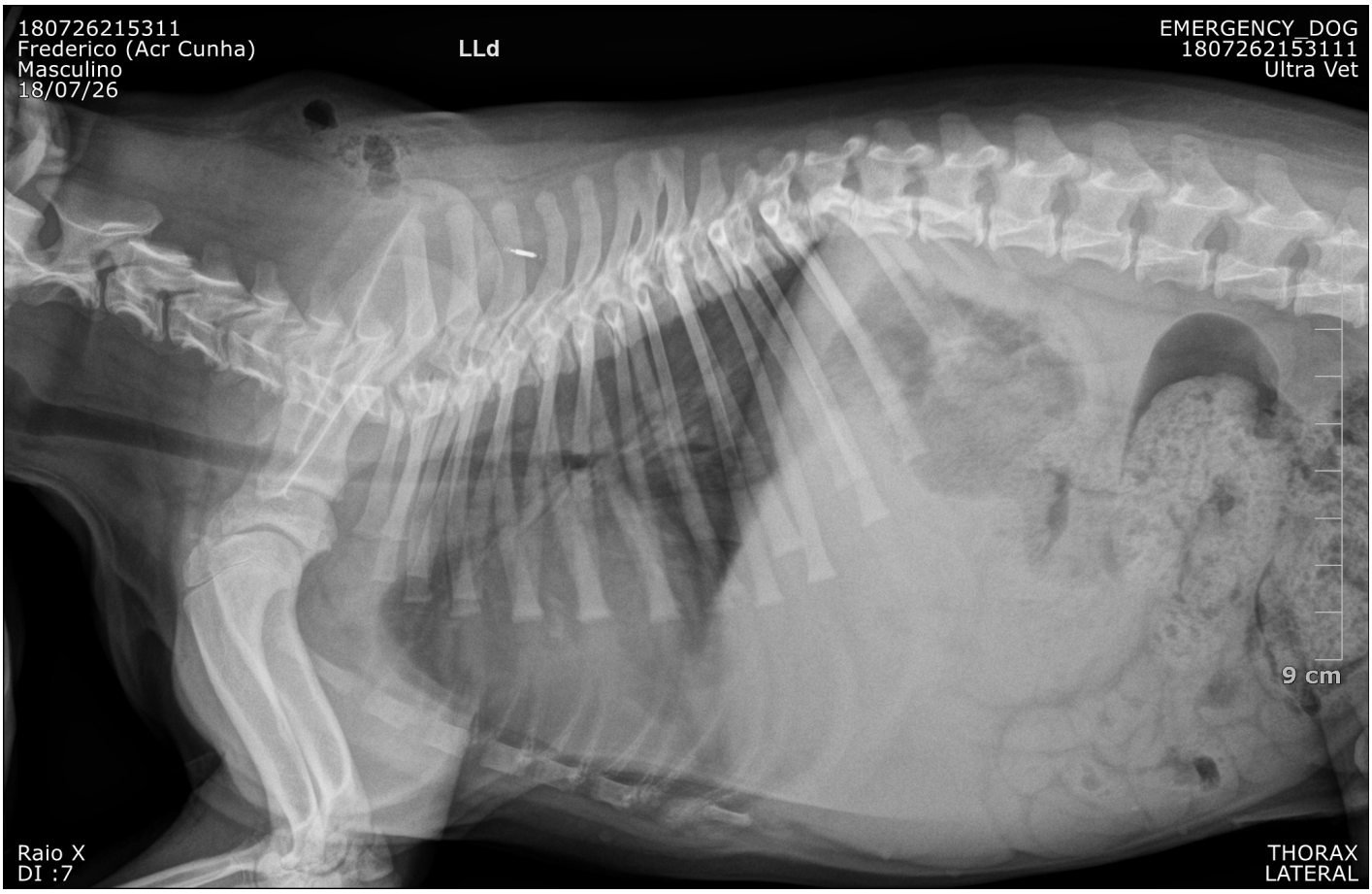
Membro do Colégio Brasileiro de Radiologia Veterinária - CBRV

Especialista em Diagnóstico por Imagem – Título Concedido pelo CFMV/ABRV



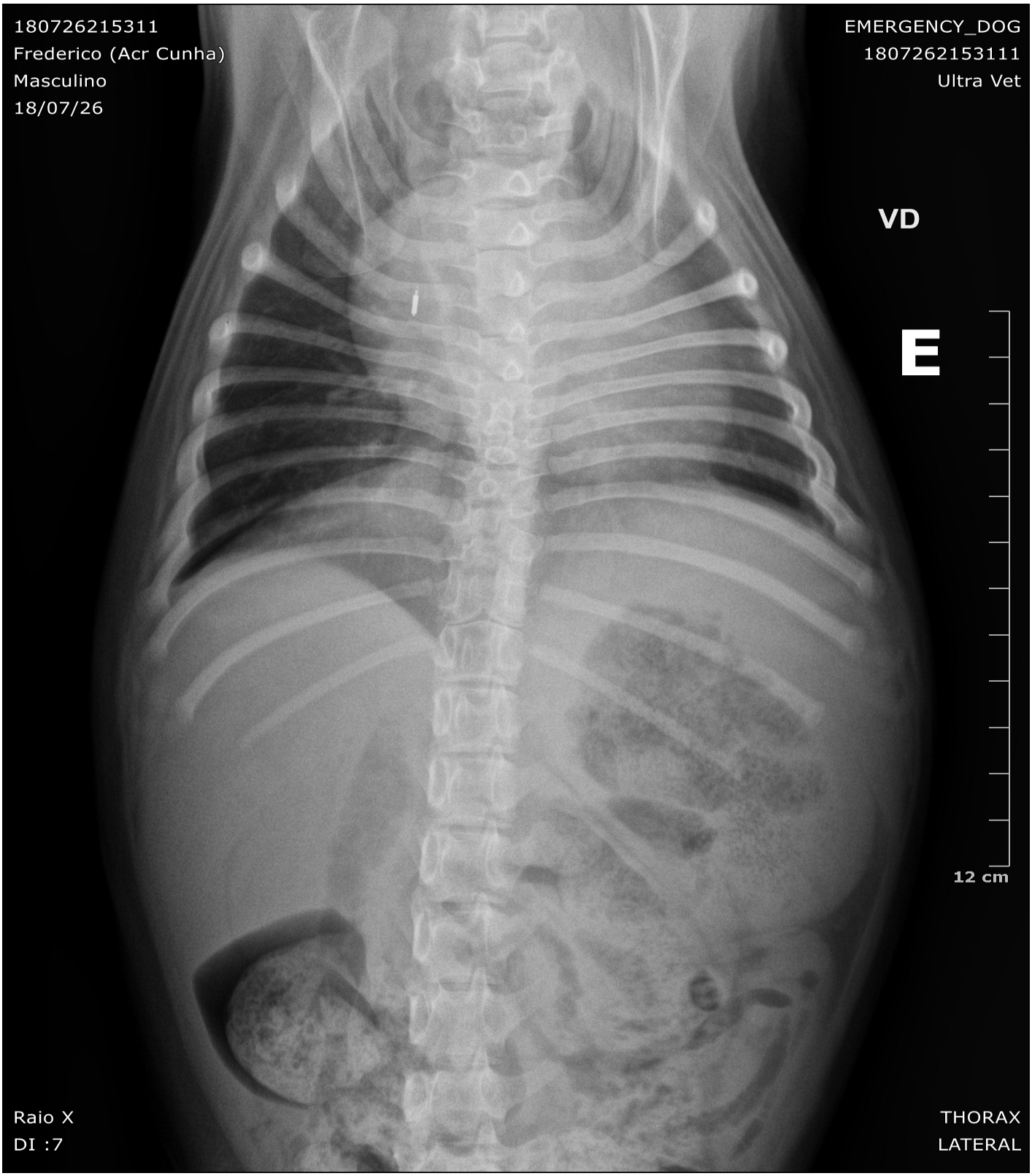
(45) 999545955
televetbr

UltraVet - Diagnóstico por Imagem Volante - Radiologia e Ultrassonografia
Endereço: Setor Hípico de Brasília, área especial, conjunto 8 70.610-000
Email:ultravet.brf@gmail.com
Cel: (61) 99624-9121



(45) 999545955
televetbr

UltraVet - Diagnóstico por Imagem Volante - Radiologia e Ultrassonografia
Endereço: Setor Hípico de Brasília, área especial, conjunto 8 70.610-000
Email:ultravet.brf@gmail.com
Cel: (61) 99624-9121



(45) 999545955
televetbr

UltraVet - Diagnóstico por Imagem Volante - Radiologia e Ultrassonografia
Endereço: Setor Hípico de Brasília, área especial, conjunto 8 70.610-000
Email:ultravet.brf@gmail.com
Cel: (61) 99624-9121